

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

loteprednol etabonate 2mg/ml

(알렉스점안현탁액0.2% 바슈롬싸우스아시아인크)

☐ 제형, 성분·함량 :

- loteprednol etabonate 2.0mg/ml
- 흔들었을 때 균질한 백색-회백색의 현탁액을 함유하고 있는 백색의 플라스틱 용기

☐ 효능 효과 :

- 계절성 알레르기 결막염의 증상 및 증후의 일시적 완화

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

2009년 제8차 약제급여평가위원회: 2009년 8월 20일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2009년 7월 13일

2009년 제11차 약제급여평가위원회: 2009년 10월 22일(재평가)

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2009년 8차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “계절성 알레르기 결막염의 증상 및 증후의 일시적인 완화”에 허가받은 약제로 대체약제인 기등재 스테로이드 점안제에 비하여 안내압 상승의 발생빈도가 감소하여 비교적 안전하게 사용할 수 있으나, 신청품 함량에서 효과에 대한 자료가 불충분하고 부작용 감소의 치료적 이익에 대한 경제성이 불분명하므로 비급여함
- 단, 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액[]를 수용시 급여의 적정성이 있으나, 허가된 고농도(0.5%) 제제가 필요하므로, 고농도 제제의 결정신청 후 급여여부 평가가 가능함

□ 재평가 심의결과(2009년 11차 약제급여평가위원회)

○ 기심의결과 유지(비급여)

- 동일성분 고농도(0.5%)제제가 필요하나 결정신청되지 않았으므로 기심의 결과를 유지함
- 또한, 제약사에서는 재평가지 대체약제로 스테로이드 점안제와 항알레르기성 점안제 선정을 요청하였으나
 - 기심의 시 스테로이드의 지속적 사용에 의한 부작용 및 그로 인한 신증투여에 대한 경고사항이 허가사항에 명시되어 있으며 교과서 및 임상진료지침이나 학회의견에 의하면 알러지성 결막염에 사용하는 스테로이드 제제는 기존의 약제에 반응하지 않거나 증상이 심한 경우 사용이 권장되는 점과 급여기준(안)등을 고려하여 기등재 스테로이드 점안제를 대체약제로 선정하는 것으로 심의되었고
 - 제약사에서 제출한 처방전 분석자료에 의하면 총 처방전 중 스테로이드 점안제는 ‘결막염’, 항알레르기성 점안제는 ‘알레르기성 결막염’에 대한 처방전의 비율로 분석대상이 서로 상이하고 처방량에 근거한 비율이 아니므로 정확한 처방비율로 볼수 없으며, 또한 스테로이드 점안제는 기존 약제에 반응하지 않는 경우등에 사용하는 제제임을 고려시 처방비율을 토대로 대체여부 판단이 불가하므로 기심의 결과를 유지하는 것으로 평가됨

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “계절성 알레르기 결막염의 증상 및 증후의 일시적인 완화”에 허가받

은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 유사 적응증에 허가 받은 스테로이드 점안제가 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성 평가

- 기존의 스테로이드성 점안제에 비해 점안 후 빠른 시간내에 비활성물질로 대사되어 안내압(Intraocular Pressure)상승률이 낮은 등 부작용의 발생 빈도가 감소하여 비교적 안전하게 사용할수 있는 제품¹⁾임
- 효과면에서 신청품 함량에서 기등재 의약품 대비 효과에 대한 자료가 불충분함
 - 신청품과 Olopatadine과의 비교시 소양감이나 충혈에서 신청품은 Olopatadine에 비해 유의하게 열등하였으며($p<0.034$) 안내압은 방문 3회 측정치가 방문1회 측정치에 비해 유의하게 높아졌음($p<0.001$)²⁾
 - 신청품의 고농도제제(0.5%)와 prednisolone acetate 1% 점안제 및 위약과의 효과비교에서 신청품의 고농도제제인 0.5%제제는 PA와 통계적으로 유의한 차이는 없었음³⁾
 - 신청품과 위약대비 임상시험에서 2주 투여후 안구결막충혈의 감소는 신청품투여군에서 -1.4, 위약투여군에서 -0.89($p<0.001$), 소양감의 감소는 신청품투여군에서 -3.03, 위약투여군에서 -2.63($p<0.008$)로 나타나 위약대비 효과적임⁴⁾
- 기존치료에 반응하지 않아 스테로이드를 사용해야 하는 경우 안압상승과 백내장의 발생과 같은 합병증의 발생이 적은 치료적 이익이 있음⁵⁾
 - 신청품의 안내압 상승에 관한 비교시험에서 안내압이 10mmHg상승한 환자는 신청품에서는 1.7%, prednisolone acetate 투여군에서는 6.7%, 위약군에서는 0.5% 발생하였음⁶⁾

○ 비용효과성 평가

- 신청품은 교과서⁷⁾나 임상진료지침⁸⁾, 학회의견등을 고려하여 기등재된 스테로이드 점안제(fluorometholone, fluorometholone acetate, prednisolone acetate, rimexolone, dexamethasone)를 대체약제로 선정함
- 제약사에서 제출한 경제성 평가자료는 비교대상과의 점증적 비용효과비를 제시하지 않는 등 「의약품 경제성평가지침」 및 자료작성요령에 근거하여 작성되지 않았으므로 경제성평가 자료로 볼 수 없음
- 신청품의 1회 투약비용은 ■■■■■으로 대체 약제가 기등재 스테로이드 점안제인 경우 대체 약제의 가중 1회 투약비용인 ■■■■■에 비해 고가에 해당됨

○ 재정 영향 검토

- 신청가격 기준

- 제약사 제출 예상사용량에 따른 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁹⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 비교약제의 대체로 재정소요금액¹⁰⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■억원 증가할 것으로 예상됨
- 다만 신청품의 검토된 급여기준(안)에 의하여 대상 환자 추정시 약 ■■■명으로 예상되어 재정소요금액은 감소할 가능성이 있음
- 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준
 - 신청품의 도입 시 절대재정소요금액¹¹⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 예상되며, 재정증분은 없음

○ 제외국 등재현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국에 등재되어 있음

Reference

- 1) 대한안과학회 ■■■■
- 2) Comparison of the clinical efficacy and tolerability of olopatadine hydrochloride 0.1% ophthalmic solution and loteprednol etabonate 0.2% ophthalmic suspension in the conjunctival allergen challenge model Clin Ther. 2002 Jun;24(6):918-29
- 3) PILOT EFFICACY AND SAFETY OF LOTE Prednol ETABONATE IN CONJUNCTIVAL PROVOCATION TEST. CLINICAL REPORT P-5604:105 IND NO: 32,432 PROTOCOL NO.: P-5604: 105
- 4) A Randomized, Double-masked, Placebo-controlled Parallel Study of Loteprednol Etabonate 0.2% in Patients with Seasonal Allergic Conjunctivitis Ophthalmology 1999; 106:362-369
- 5) 대한안과학회 ■■■■
- 6) Change in Intraocular Pressure During Long-Term Use of Loteprednol Etabonate Journal of Glaucoma Vol. 7 No. 4 Aug 1998
- 7) Yanoff & Duker: Ophthalmology, 3rd ed, Middleton's Allergy: Principles and Practice, 7th ed
- 8) Eye : American College of Occupational and Environmental Medicine (ACOEM); 2004. 77 p
Conjunctivitis : American Academy of Ophthalmology 2008
- 9) 절대재정소요금액 = 제약사의 예상사용량× 신청가■■■
- 10) (신청품의 가격- 모든 대체약제의 가중평균가)× 제약사의 예상사용량
- 11) 절대재정소요금액=모든 대체약제 가중평균가 x 제약사제시 예상사용량